EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 68292
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 31-07-2023

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUCIA DEL CARMEN VIVANCO GONZALEZ			RUN	: 12.117.267-4
F.Nac	: 28-03-1970	Edad	: 53 AÑOS, 4 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: PASAJE CALAFQUEN 523, L DE CHILE			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 90673105		
Fecha Ingreso	: 2023-07-27	Fecha Egreso	: 31-07-2023	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

PIELONEFRITIS AGUDA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

AP ASMA
ALERGIA NIEGA

PACIENTE QUE INGRESA EL 27/07 POR CUADRO DE 3 DÍAS APROXIMADAMENTE PRESENTANDO DOLOR EN HEMIABDOMEN DERECHO, PREDOMINIO EN HIPOCONDRIO DERECHO, EPIGASTRIO, ASOCIADO A NAUSEAS SIN VÓMITO Y AUMENTO DE TEMPRATURA CORPORAL NO CUANTIFICADA.
PARÁMETROS INFLAMATORIOS FRANCAMENTE ALTERADOS, EPISODIOS DE HIPOTENSIÓN DURANTE ESTANCIA. SE INICIA SOPORTE DVA PREVIO A ENVÍO A HCHM.
ACTUALMENTE PACIENTE EN MEJORES CONDICIONES GENERALES, SIN REQUERIMIENTOS DE DVA. /ME COMUNICO VIA TELEFÓNICA CON DR. VERA INFORMO RETORNO DE PACIENTE.
SEGÚN HALLAZGOS DE TC, SOLICITA VALORACIÓN POR CX/PACIENTE CON SEPSIS DE FOCO NO DEFINIDO SOLICITAN EVALUACION POR DOLOR ABDOMINAL. PACIENTE ACTUALMENTE HDE SIN DVA AFEBRIL. SIN DOLOR ABDOMINAL ACTUALMENTE. TRAE TAC DE CHILLAN QUE EVIDENCIA COLELITIASIS SIN SIGNOS DE COLECISTITIS AGUDA CON GRAN AUMENTO DE VOLUMEN RENAL IZQUIERDO CON EOC (+) ITU
SE RECIBE INFORME DE TAC SUGERENTE DE NEFRITIS IZQUIERDA A CORRELACIONAR CON ESTUDIOS DE LABORATORIO. ATROFIA RENAL DERECHA.
SE INGRESA Y SE ADMINISTRA CEFTRIAXONA POR 5 DÍAS, CON EVOLUCIÓN FAVORABLE, PARÁMETROS INFLAMATORIOS EN DESCENSO, POR LO QUE SE DECIDE ALTA HOSPITALARIA CON ADMINISTRACIÓN DE CEFTRIAXONA PARA COMPLETAR 10 DIAS CON HOSPITALIZACION DOMICILIARIA

PLAN DE MANEJO:

REALIZAR NUEVO UROCULTIVO AL TERMINAR TRATAMIENTO MEDICO EV

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO POR 1 SEMANA
2. REGIMEN LIVIANO CON ABUINDANTE LIQUIDO 1.5LTS DIA
3. CEFTRIAXONA 2 GR DIA EV POR 4 DÍAS
4. RESTO DE MEDICACIÓN CRÓNICA DE FORMA HABITUAL

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Mariana Panique Pedraza
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO